# 大 腸 直 腸 肛 門 外 科 操 作 手 冊

## 序言

大腸直腸肛門外科主要為處理大腸直腸癌，大腸相關疾病及肛門疾患的病人。大腸直腸之解剖生理有其特殊之處，因此在面對這類病人時，亦有一些初學者生澀之處。

近年來，隨著生活型態之西化，大腸直腸癌已躍居癌症十大死因之第三位及癌症發生率之第三位（行政院衛生署統計，民國 95 年）。手術切除腫瘤部位仍是目前治療之主軸，再輔以日新月異之化學治療及放射治療。大腸直腸癌病人之存活率，已較以前進步許多。

肛門疾病（痔瘡、肛門瘻管等）亦是現代人常面臨的問題，一般人對其症狀及治療方式皆不甚了解，亦不知該如何防範。來到大腸直腸肛門外科，將學到肛門之解剖生理以及常見之手術治療方式。

另外，在大腸直腸肛門外科，亦須學習腸道準備之原理及方法，以及腸造口之時機與相關問題之處置。

希望經由這樣的介紹，能使醫學生及住院醫師更容易進入這個領域，並解答臨床工作常見的疑問。

**大腸直腸手術，病人術前、術後的工作規範**

(一) 前言

大腸直腸手術大多為癌症病人。其手術方法以部份不同有不同方法。因大腸直腸為糞便貯藏的部位。術前之準備也因而與一般手術有異。術後的一些病人可能設有人工肛門，即結腸造口，術後護理也與一般手術後有所不同。

(二) 主要工作

1. 協助實習醫師七年級及住院醫師照顧病人。
2. 務必參加科內學術活動。

(三) 大腸直腸手術病人住院例行檢查項目

l. CBC, U/A, Sugar, CEA (CA19-9), Na, K, Cl, GOT, GPT, Albumin, T.Bili, BUN, Creatinine
   Chest X-ray, EKG
   Liver Echo or CT Scan of Abdomen
   Colonoscopy & Biopsy, and/or BaE (DCBE)
2. 因病情需要可能加上
   IVP, Bone scan, Cystoscopy, Pul. Function test, Cardiac echo 等
3. 年齡 60 歲以上者或 EKG 有所見者需會診心臟內科

(四) 手術前準備事項

l. 通常病人於預定手術前二日住院。
2. 除非另有醫囑，一般予流質飲食。
3. 確認有無 IVP 及 BaE 和大腸鏡檢查，如病人有外片者，亦請示醫師可免重覆檢查(請摘要影印外片存檔)。

4. Barium Enema 檢查準備事項 (切記: 腸阻塞病人，作 BaE 之前，應與主治醫師討論)

   檢查前一日應予清流飲食

   Mag. Citrate Soln. 250cc at 6:00 pm

   Dulcolax Tab. 3 tab at 7:00 pm

   Dulcolax Supp, l piece at 9:00 pm per anus

   Dulcolax Supp, l piece at 6:00 pm 次晨

5. 腸道的準備 (切記: 腸阻塞病人，以下之腸道準備，應與主治醫師討論)

   #右側大腸或APR手術

   手術前一日: 清流食物

   Phosphosoda 90cc 分兩次，加360cc水或飲料

   於3PM及6PM服用。

   #左側大腸或LAR手術

   手術前二日: 全流食物

   手術前一日: 清流食物

   Phosphosoda 90cc 分兩次，加360cc水或飲料

   於3PM及6PM服用。

   #Fasigyn 4 piece preop night

   Antibotics at op day 6:00 am 並帶一支至OR以備手術

   Antibiotics應可以cover gram positive, gram-negative及 anaerobic bacteria為原則。

6. 填寫手術志願書，並確認病人確實對於手術內容有瞭解。

7. 半夜12時以後禁食。(高血壓藥物除外)
8. 手術當日set up lV line。
9. 病人Hb低於10.0者，請示醫師予輸血。

(五) 手術前準備應注意事項

l. 有腸造口可斟酌瀉藥，送ST Room做人工肛門灌洗。(手術前一日及當日)
2. 疑似腸阻塞或腹膜炎病人勿給瀉藥。
3. 疑似大腸炎病人勿給 Dulcolax Tab 及 Suppository，如予灌腸宜使用Saline Enema。
4. 疑似腹膜炎病人勿給予灌腸。
5. 灌腸當中隨時注意病人情況。
6. 如例行檢查有異常者，隨時通知醫師。
7. 癌症病人，切記要追回切片報告。

（六）術後護理

l. Vital signs q.2h for 24 hours, then q.8h。
2. I&O, q.1h for 6 hours, then q.8h。
3. 注意傷口、引流、會陰、肛門之出血。
4. 注意electrolyte, Hb。
5. 傷口：
    1) Clean/clean contaminated wound: dry care
    2) Contaminated/dirty wound (包括人工肛門)以Normal Saline紗布wet dressing, q.4h~q.8h, 1-3天。
6. 如有 Sump Irrigation Suction Drainage者，每小時注意查看並注意I&O量，q.4h記錄。如灌入量多於吸出量，即調慢灌入量，

並通知醫師。

7. 如有腸造口者，注意造口顏色、出血、腫脹等情形。

8. *如有下列情形即時通知醫師。

a. 脈博120次以上或不整脈者。

b. 呼吸緊迫或呼吸困難，唇、臉、手指變紫色者或煩燥不安。

c. 血壓在100 mmHg以下或180 mmHg以上者。

d. 尿量在每小時25cc以下者。

e. 有異常出血者。

f. 人工肛門顏色有變化或排出量異常者。

g. 體溫有38°C以上者。

h. 意識不清者。

9. 鼓勵病人翻身，深呼吸及咳痰，Chest care q.4h。如需要可會診呼吸治療，作post-op chest case。

10. 有NG tube病人需每二小時抽一次，並予記錄。

11. 如有Hemovac引流者，需注意引流功能和流出物顏色，並q.8h記錄引流量。

12. 止痛藥通常用Demerol 50mg q4h IM PRN。老人(70歲以上者)宜減半量。如以通常量未能止者，或需求頻繁，宜通知醫師調整。

13. 用PCA病患應注意呼吸速率。

(七) 術後護理應注意事項:

l. 大腸直腸手術往往合併膀胱手術之故，因此未有醫囑，請勿任意拔掉留置尿管。

2. 通常APR病人尿管需留置7-10天，不要任意更換。

3. 尿量在每小時25cc以下時，請先檢查尿管有無折扭或阻塞Vital Signs有變化，以及尿比重，再通知醫師。

4. 有留置尿管者需每日尿管護理，保持乾淨。

## 一、肛門疾病開刀病人術前、術後的工作規範

(一) 開刀前準備事項

1. 通常病人於開刀前一日住院

2. 開刀前例行檢查

   a. CBC

   b. Chest X-ray

   c. E.K.G.: 凡45歲以上者，有高血壓或心臟疾病者，肥胖者。

3. 填妥手術志願書，半夜12時以後禁食。

4. 不必皮膚消毒、剃毛。

5. 手術當日早晨5時，給予Fleet enema x 2Pc (灌腸如另有醫囑之外宜於預定開刀時間至少二小時以前給予)，灌前後必須查看其效果，有必要者，重複給予。

6. 依醫囑給予手術前給藥 (premedication)。

7. 下列情行給予抗生素 (依醫囑處理)。

   a. 嚴重脫肛併栓塞壞死性痔瘡。

   b. 肛屢併急性感染。

   c. 肛門周圍或高位膿瘍。

8. 凡有感染或膿瘍病人必須依規定填妥感染報告，並取樣本送檢驗做細菌培養。

9. 依病人之需要請醫師開給止痛藥

   Ponstan 2 caps stat 及 q6h ~ q8h 或 Scanol 2 tab stat 及 q6h ~ q8h

   Demero1 50mg q4h PRN (手術當日)

10. 除醫囑另有指示外，開刀前一日可給普通食物。

11. 對於嚴重脫肛，栓塞性痔瘡等病人可用坐浴以減輕疼病。

12. 判讀例行檢查的 Data。

(二) 開刀後病人之護理及注意事項:

1. 從恢復室回病房之病人，除了所規定護理工作之外，應注意呼吸道，開刀部位 (肛門) 有出血，如果使用丁字帶者，要檢查是否過緊，在恢復室有無給 Demerol，有無尿意，有無腹脹等現象。

2. 靜脈輸液通常於病人完全清醒後可以停止，但有大量出血血壓低或不穩定者，或醫囑另有指示者，應保持輸液。

3. 飲食: 全身麻醉者完全清醒後，當日給予流質。惟有排尿困難者不宜多飲。開刀次日開始。給予普通飲食 (稀飯) 。半身麻醉者，當天就可給予普通飲食。

4. 麻醉未完全清醒前或病房 4 小時內應常巡視病人，check vital signs。有異常時隨時聯絡醫師。

5. 應隨時注意有無肛門出血記錄出血情形及估計出血量。

6. 開刀後病人使用鬆紗布等壓迫包紮，目的在於壓迫開刀部位以減少出血、溢血及血塊形成。除非為了解尿及查看有無出血外，儘量維持壓迫包紮 8 小時。

7. 導尿: 肛門開刀後，病人因疼痛、壓迫包紮等緣故，常有解尿困難之現象; 病人清醒者，可扶起站立或坐位解尿或稍鬆弛丁字帶，盡量鼓勵起解。應於每 4-6 小時詢問有否解尿。若在 6-8 小時內未解者，或許脹尿未解者，給予導尿，導尿時務必注意無菌操作，並適度潤滑以防感染或尿道受傷。

8. 麻醉清醒後，病人可自行起床行動，惟在開刀當

日，宜囑有人陪伴，以免發生意外。

9. 開刀次日，開始溫水坐浴，每天早晚二次，坐浴約為5-10分鐘不宜週久。病人可順便洗澡。

10. 每次坐浴後，帶病人到治療室治療，早晚各一次(隨帶Neomycin ointment或Proctocedy1 Oint)。

11. 每位病人開刀後，除醫囑另有指示外，發給一支Neomycin ointment (30gm)，或Proctocedy1 Oint(28gm)。

12. 止痛藥: Demero1 50mg q4h PRN

Scanol 或 Ponstan 2 Cap q6h ~ q8h

13. 對於痔屢，開刀後，往往在創口內填塞Iodoform gauge，於翌日取出。

14. 對於高位屢開刀後， 病人有時須作直腸沖洗 (Rectal irrigation)， 務必帶至治療室。

15. 肛門開刀後創口大量出血者，其原因多半為大便崁塞過多，縫線過早斷裂，創口裂開或發炎感染等情形。先給予清水灌腸約300-500 cc。

16. 排便: 通常開刀後當日或次日病人訴有腹脹及便意，乃係因壓迫包紮所致的氣脹; 通常在第二日後才有排便。排便後應囑病人溫水坐浴清洗後，到治療室灌腸，灌腸宜用高位灌腸。

17. 不要依病人需求給予任合瀉藥或Dulcolax Supp。

18. 發燒病人不宜使用ASA或Inteban Supp。

19. 出院病人

(a) 應給追蹤天，依醫囑來門診複查並代為預約掛號。

(b) 囑病人出院後，有排便困難或多量出血應來院灌腸或處理。(林口九樓治療室)

(c) 帶回Ointment，紗布、膠布、棉棒、止痛藥，或軟化大便

藥。

(三) 肛門開刀後，病人出院需知

1. 出院時在護理站索取止痛藥，或醫師開給的藥。
2. 出院前在治療室索取敷料。
3. 每日繼續坐浴二次，並自行敷藥。
4. 每日排便後，以溫水清洗肛門，坐浴後敷藥。
5. 出院後可能繼續會有少量出血或敷料上沾血，不必驚慌，惟如有多量出血，血塊解出或出止，應即時來院處理。(時間外請至急診室,由外科值班醫師聯絡直腸肛門外科主治醫師)。
6. 出院後如有便秘或排便困難，請於門診時間內到治療室灌腸。不宜自行灌腸，不要服用瀉藥。
7. 飲食應避免酒、辣椒等刺激物，飲食宜採流質，或正常飲食適量。
8. 出院後一週內不宜過度勞動或坐立過長久。
9. 一週後來門診複查。